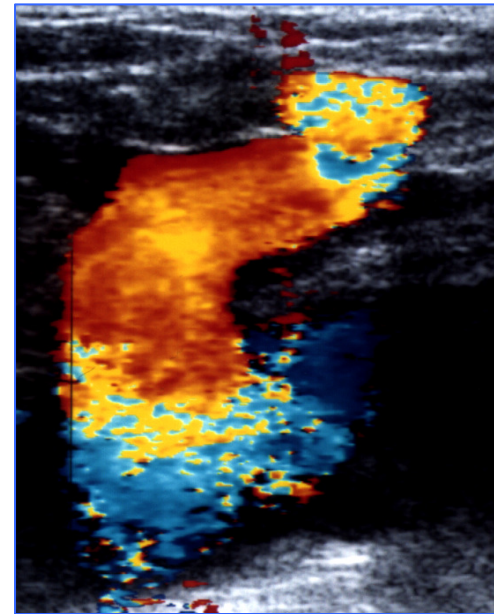
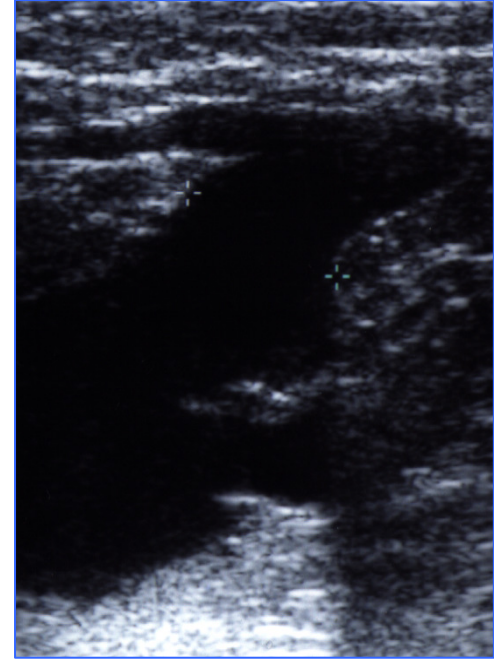


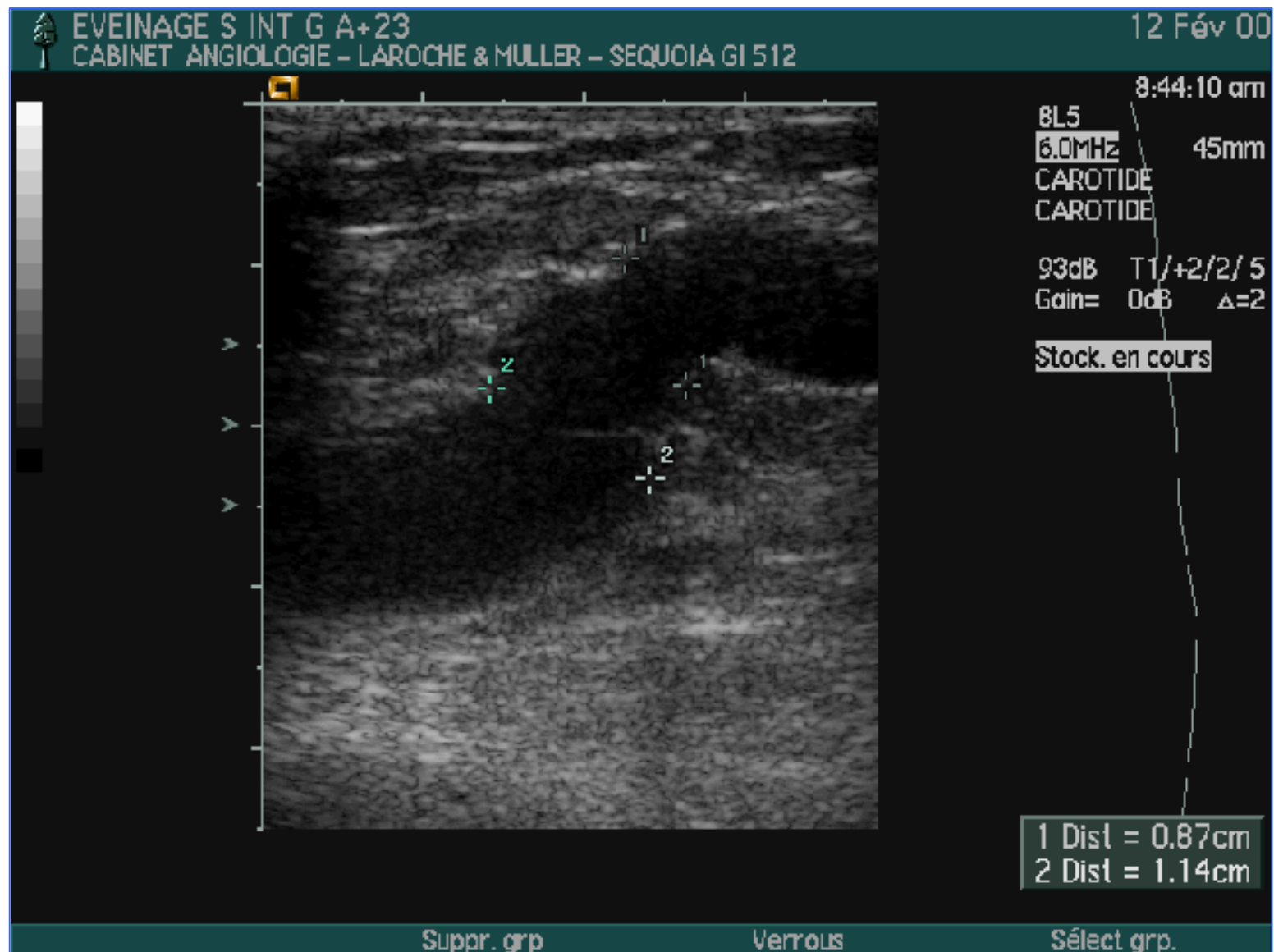
L'insuffisance Veineuse et les Varices

Jean-Pierre Laroche
CHU de Montpellier

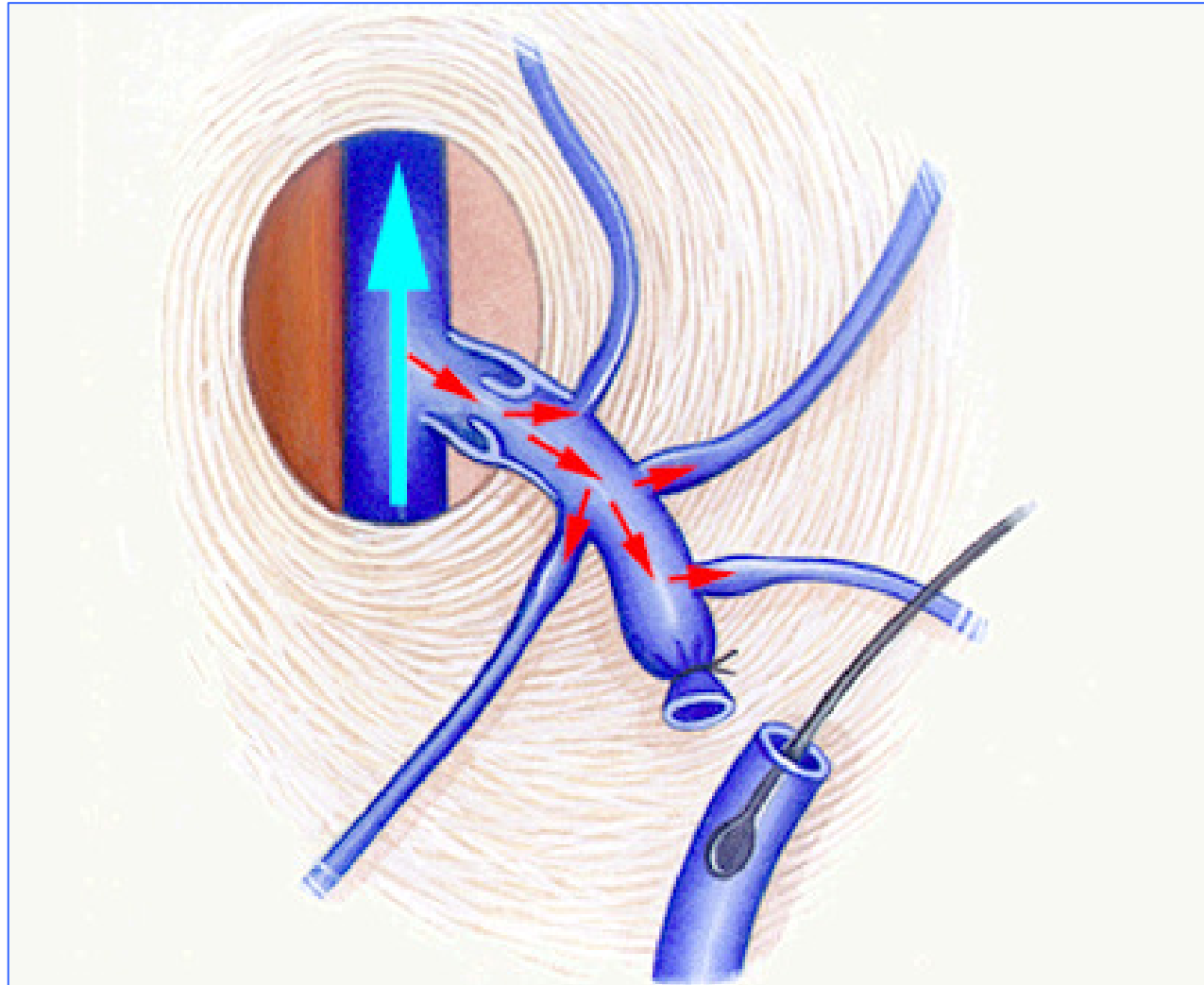
4^{ème} Partie

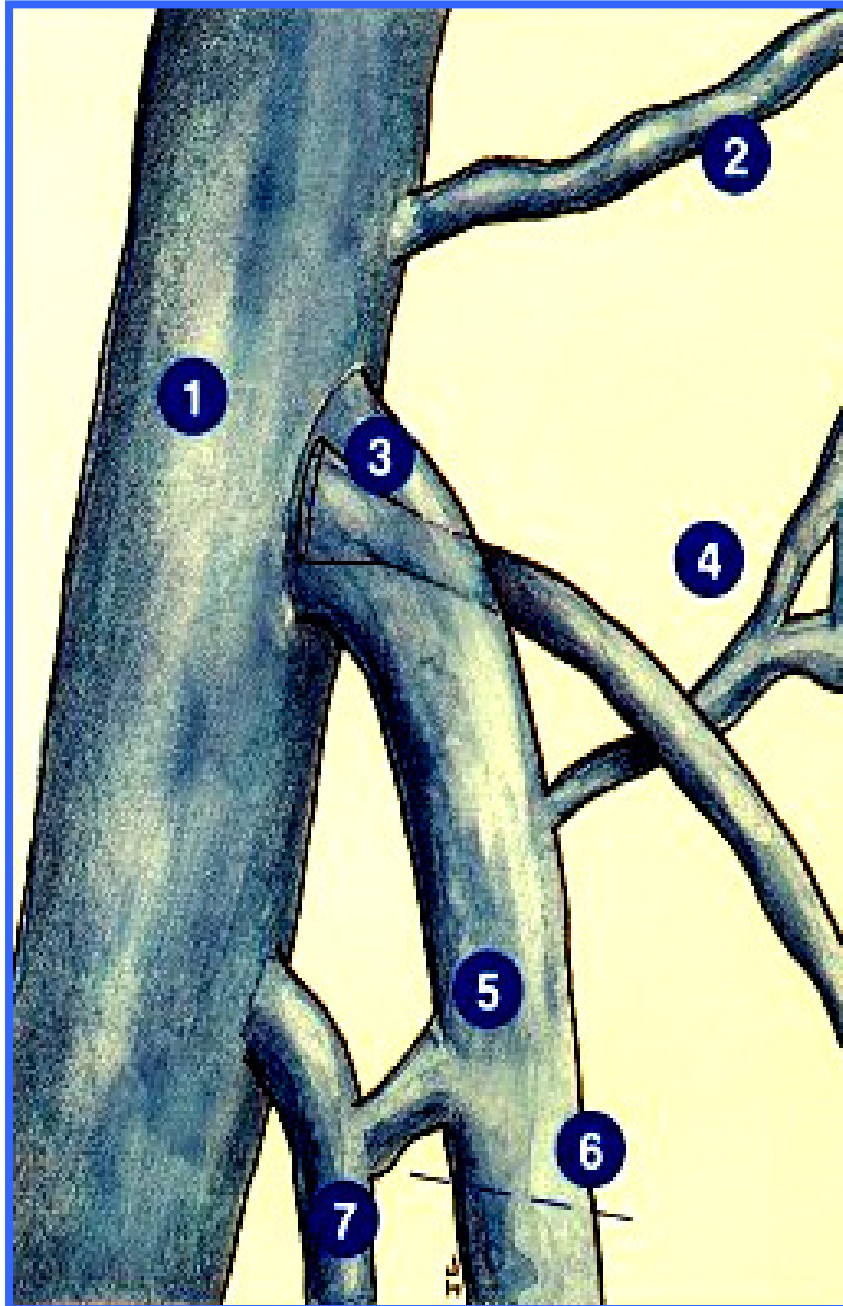
Les récidives





Crosse VGS, crossectomie A + 23



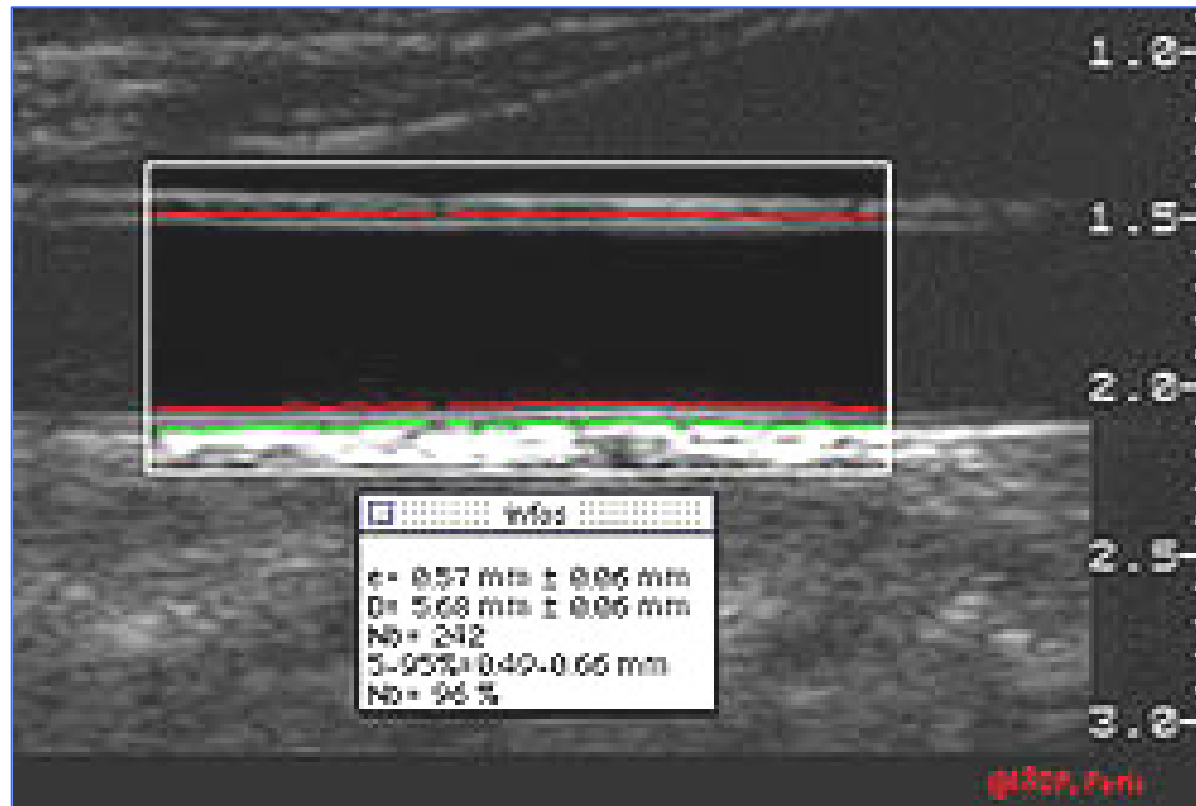


1. Veine fémorale commune
2. Collatérale
3. Branche antérieure sous fasciale
4. Réseau pelvien
5. Perforante haute
6. Moignon de crosse
7. Saphène accessoire

*Récidives Post
Crossectomie*

Le futur

Le complexe intima média de la veine



Mesure automatisée
(Plate-forme IôDP) :
Augmentation EIM
liée à l'IVS.
Normale < 0,40 mm
Régression EIM
sous traitement ?

Le reflux veineux en 3 dimensions

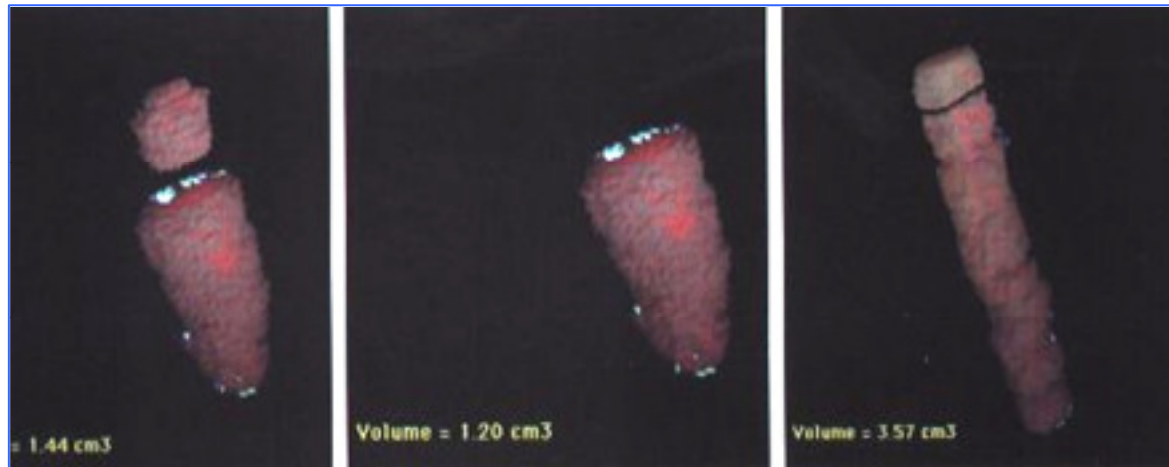
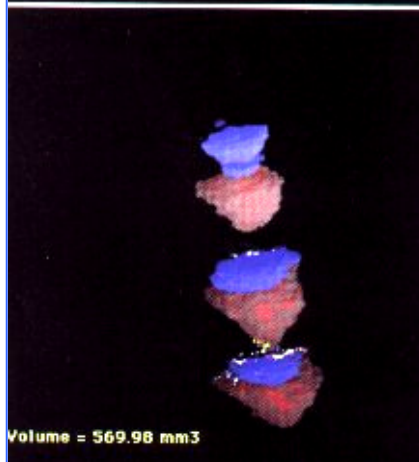
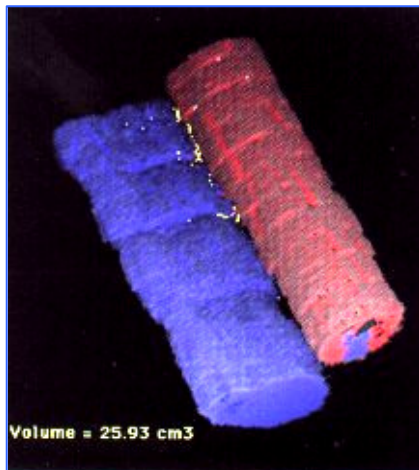
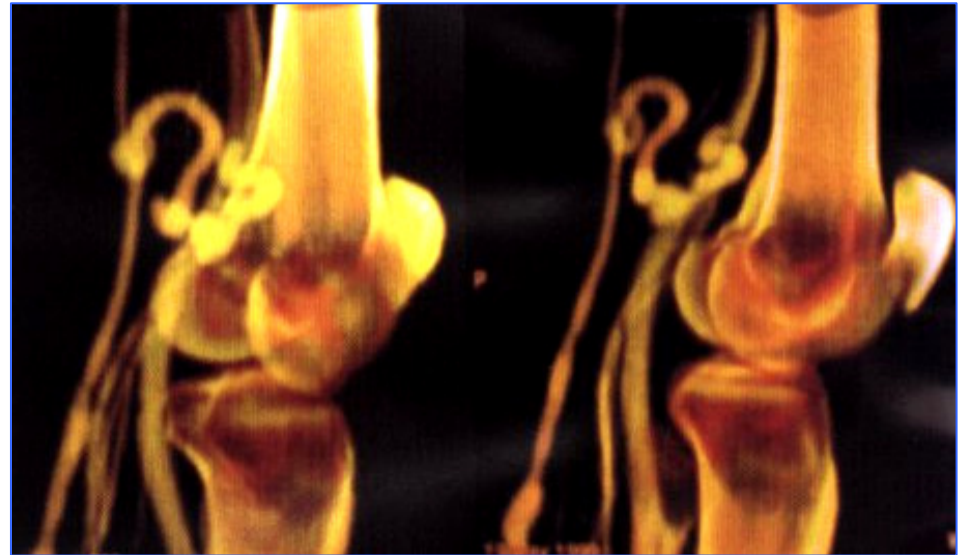
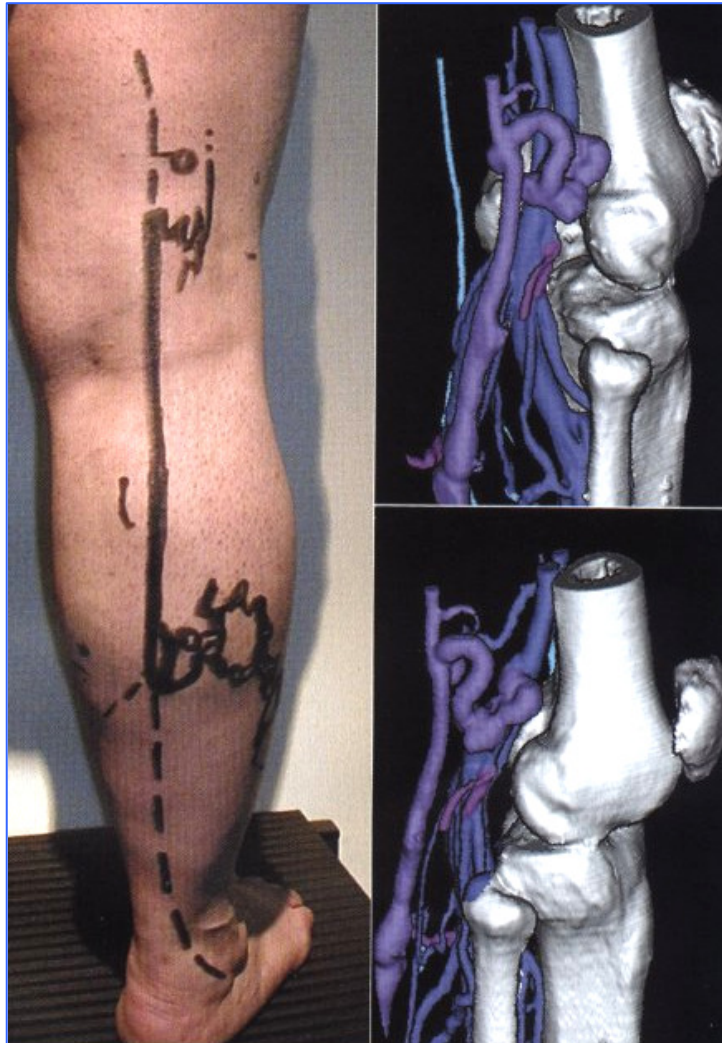


Plate-forme automatisée lôDP
Technique non validée (*Ph Caillard*)
Volumétrie des reflux
Choix discriminatif
d'une thérapeutique ?

Phléboscan hélicoïdal



Imagerie du système veineux 3D

5. REFLUX D'ORIGINE PELVIENNE

Enorme récidive post-opératoire avec reflux pelvien et large communication fémorale

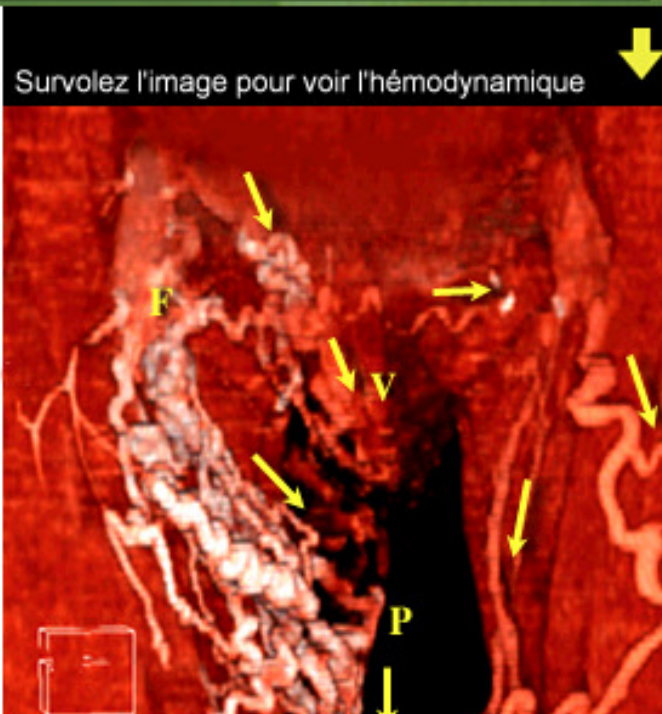
Femme de 34 ans opérée de varices il y a 5 ans, et ayant eu deux grossesses depuis. Volumineuses varices périnéales (P), vulvaires (V) et du membre inférieur compliquées de pigmentation avec eczéma.

- LE DUPLEX VEINEUX couleur montre une communication fémorale (C) large à laquelle s'associe un reflux de la veine de Giacomini et du réseau périnéo-vulvaire (cf cas n° 22) qui alimentent un reflux majeur de cuisse.

La grande saphène est présente en sus et sous-goniale.

- LE PHLEBO-SCAN hélicoïdal réalisé par ponction de cuisse montre les connections périnéo-vulvaires ainsi qu'un important réseau de cuisse alimenté par le reflux associé de la JSF.

L'origine pelvienne du reflux vulvaire (V) n'est pas clairement identifiable, mais on note une dilatation de la veine du ligament rond (R) qui passe à travers l'orifice inguinal (i).



Survolez l'image pour voir l'hémodynamique



Noter les connections avec les veines honteuses externes (He) et le système saphénien contro-latéral par les anastomoses (A) sus-pubiennes.

Imagerie du système veineux 3D



4. RECIDIVE FOSSE POPLITEE



Récidive post-chirurgicale. Cavernome poplitée

Homme de 53 ans avec cavernome de la fosse poplitée, dû à une récidive 5 ans après un éveinage de la petite saphène droite.

- L'ECHO-MARQUAGE CUTANE montre un énorme réseau variqueux dilaté du mollet et de la jambe, alimenté par un long moignon résiduel de crosse de la petite saphène, implanté 4 cm au-dessus du pli de flexion du genou sur la face externe de la veine poplitée.

Noter les perforantes basses de ré-entrée Cockett (C) en dedans, et péronières (P) en dehors.

- LE PHLEBO-SCAN précise l'anatomie complexe du cavernome qui masque la jonction saphéno-poplitée.

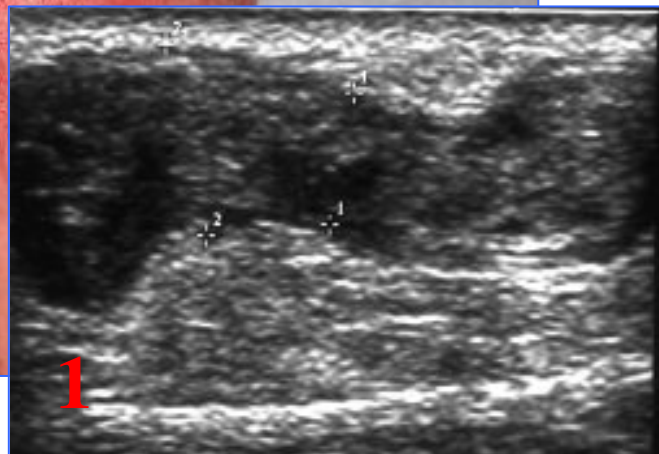
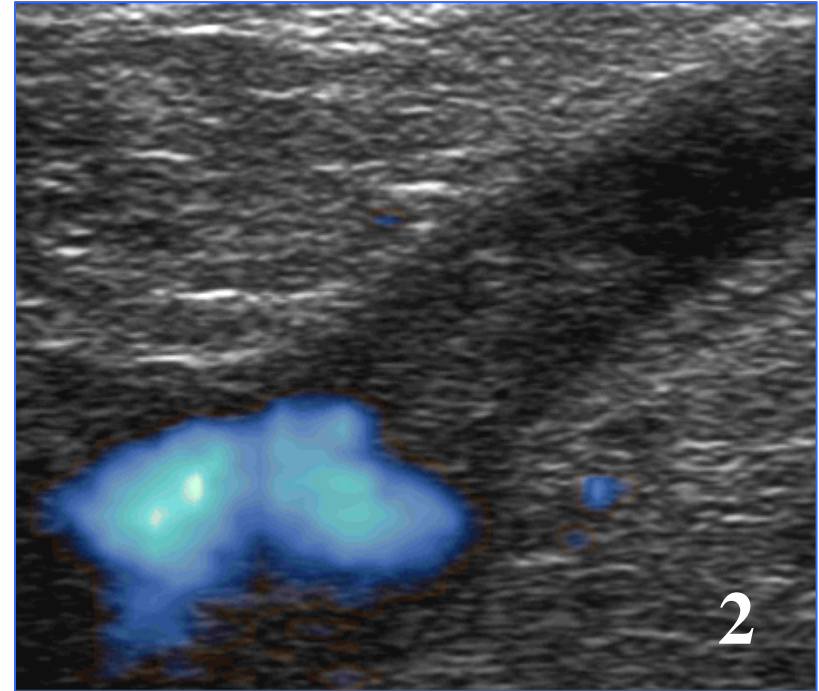
Voir écran suivant pour l'animation 3D.



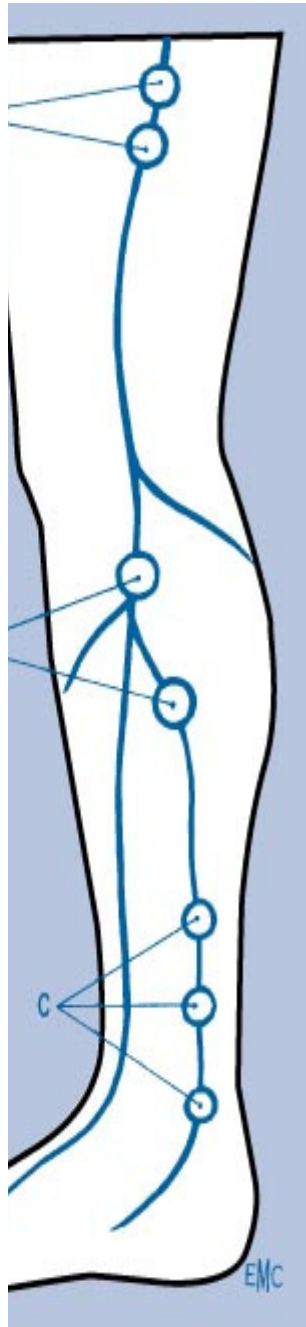
Survolez l'image pour voir l'hémodynamique



Thrombose veineuse superficielle



TVS

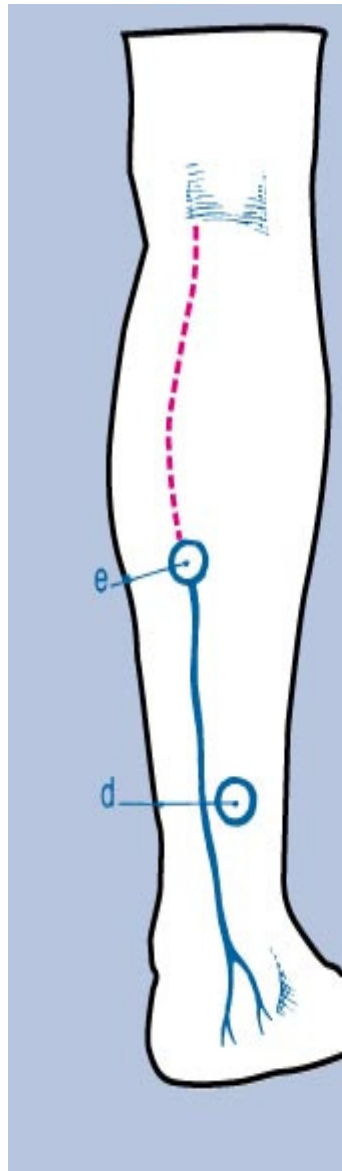


AINS local + HBPM thérapeutique
Contention Classe 2
Crossectomie/Éveinage

AINS local + HBPM thérapeutique
Contention Classe 2
Marche

AINS, local + per os
Contention Classe 2
Marche

PS



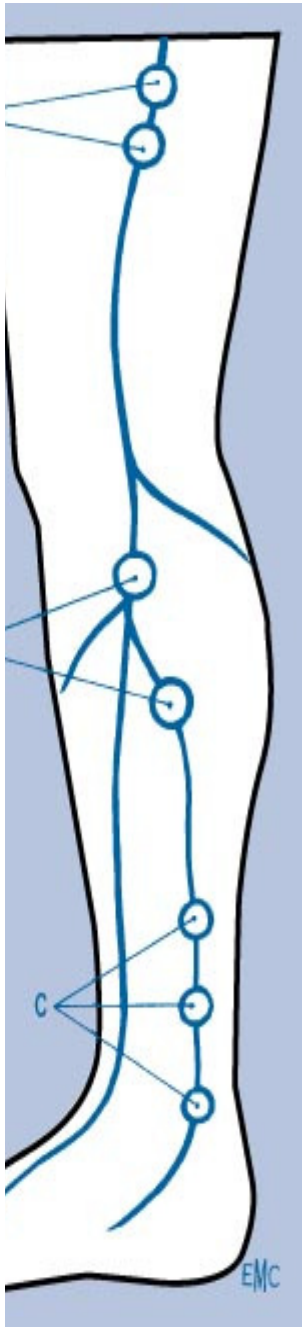
Crosse

AINS local + HBPM thérapeutique

Contention Classe 2

Crossectomie/Éveinage

AINS, local + per os
Contention Classe 2
Marche



Perforante

AINS local +HBPM thérapeutique
Contention Classe 2
Marche

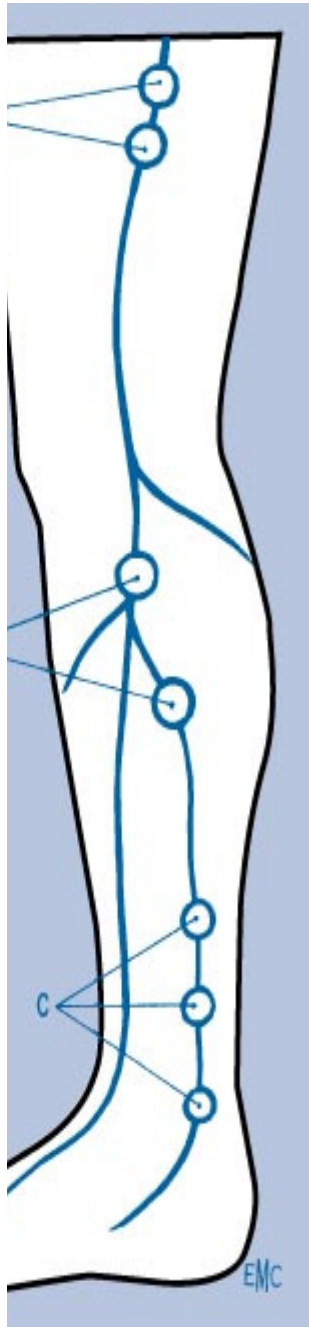
Durée HBPM en cas de TVS :

15 jours à 3 semaines

- * 15 j si pas d'autres FdR que les varices

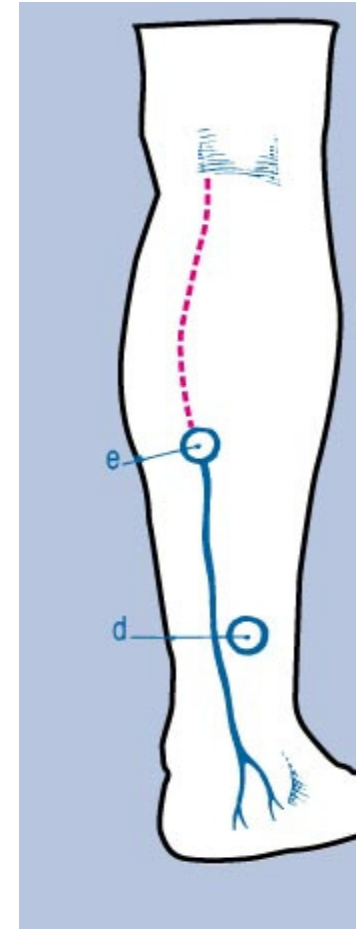
- * 3 semaines si autres FdR

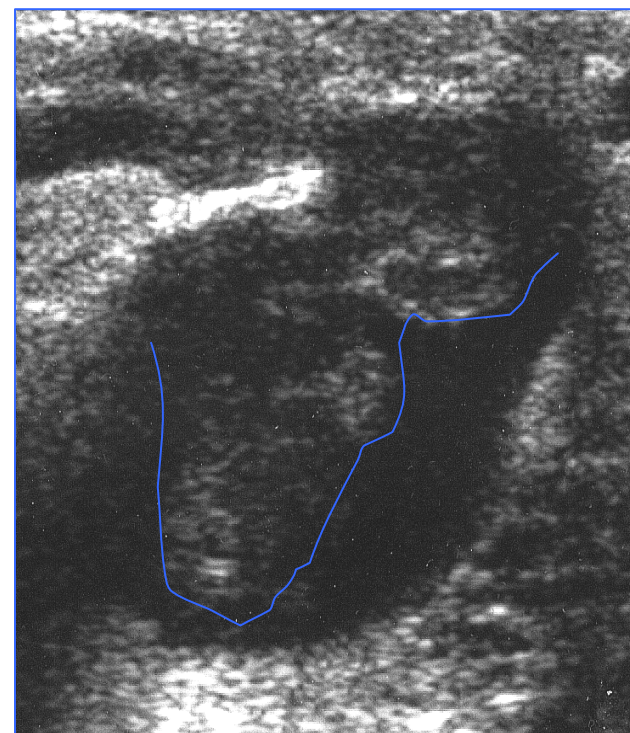
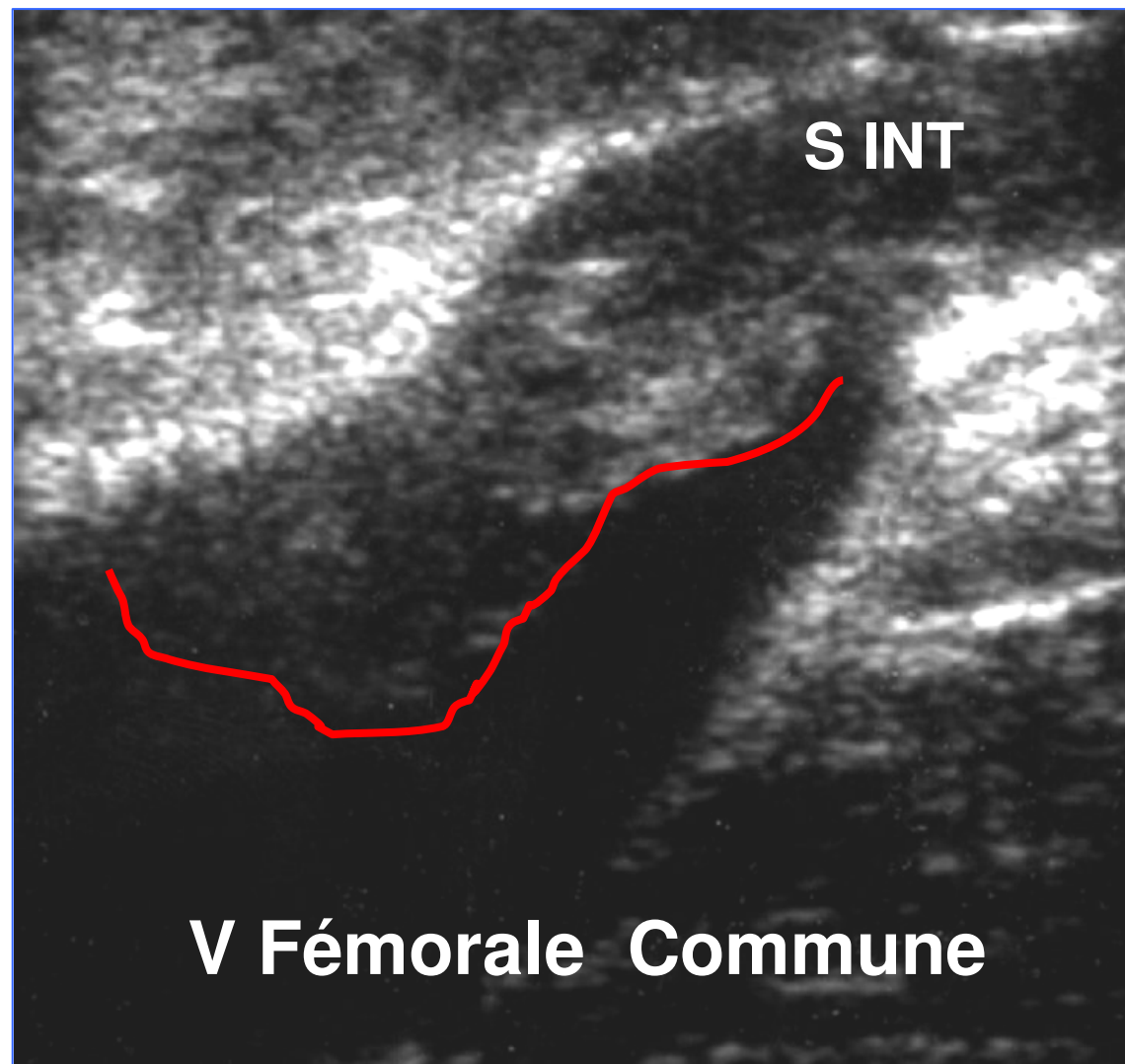
Relais AVK : exceptionnel

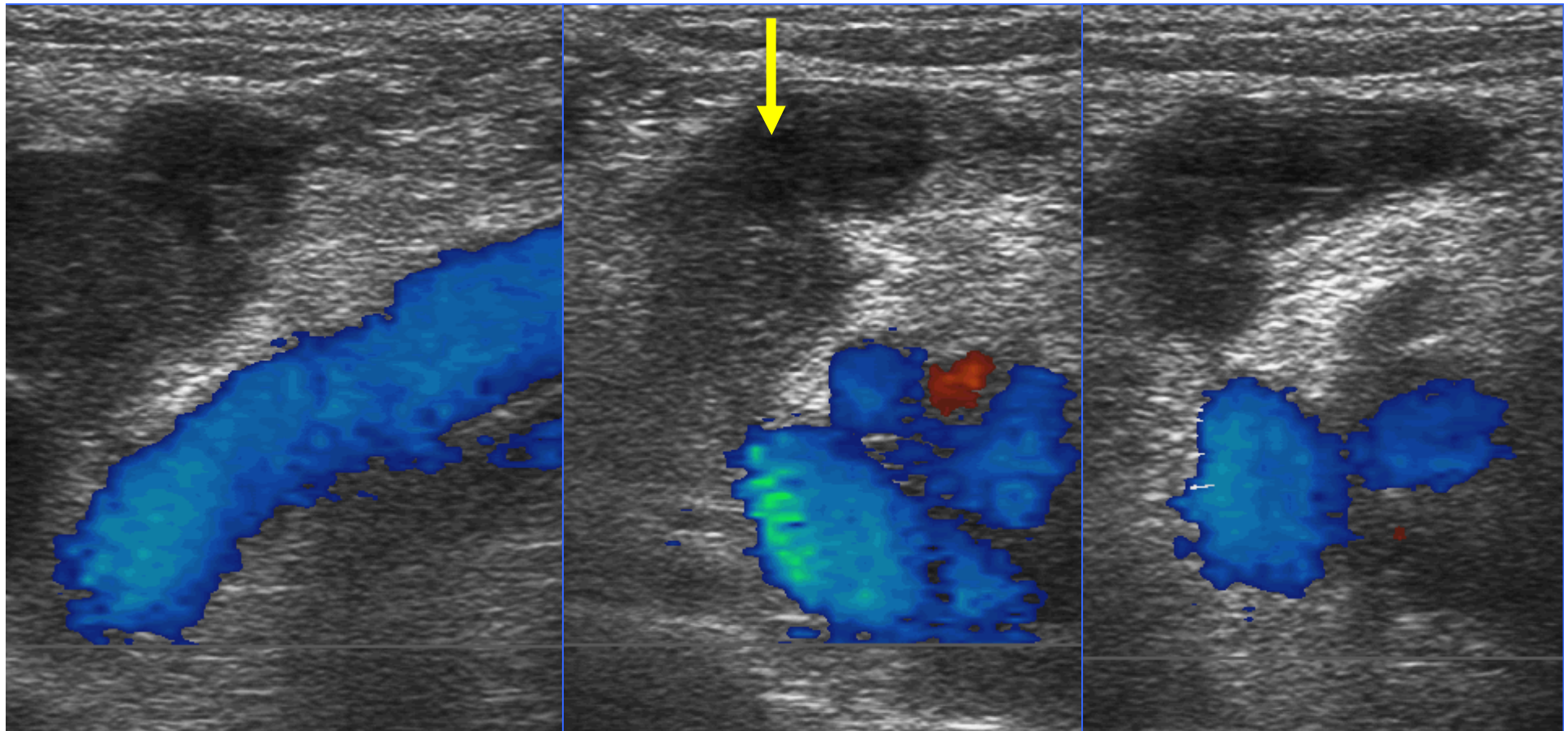


Les grandes règles

1. Ce n'est pas une affection banale (« para phlébite »)
2. Toujours rechercher une TVP associée en Écho Doppler
3. Toujours penser qu'une EP peut être présente
4. TVS + TVP par extension : 17%
5. TVS + TVP association : 15%
6. TVS + EP = 10%
7. TVS + Thrombophilie = 20%
8. TVS : veine variqueuse
9. TVS : veine saine
10. TVS : une complication des varices qui doit provoquer leur exérèse.



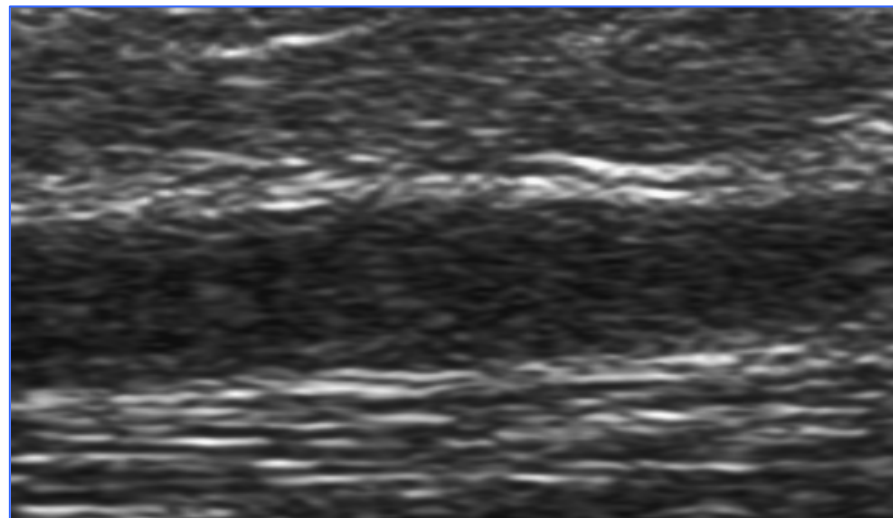


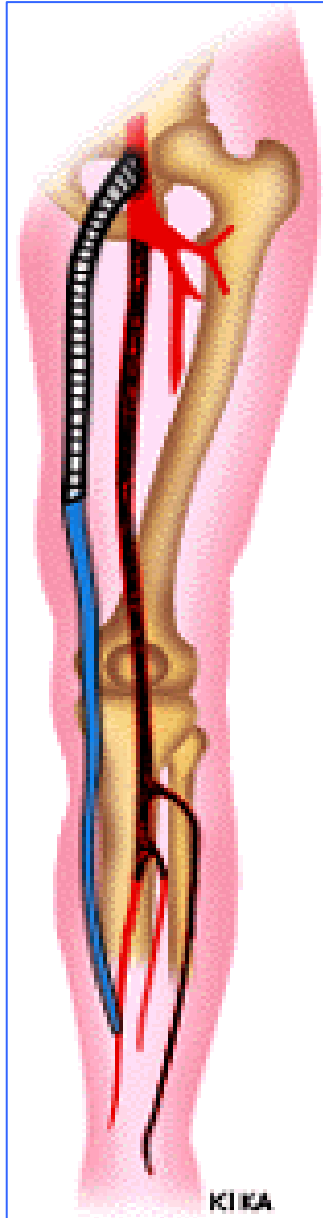


Thrombose crosse petite saphène

Traitement TVS : Veine saine

- Attention : une TVS sur veine saine est la plus part du temps l'équivalent d'une TVP surtout si elle survient de manière spontanée, dans un territoire inhabituel.





***Saphène
Pontage idéal***

The End